リハ医療デイリー

REHA MEDICAL DAILY

2026年11月3日（火）
第52号 朝刊

きょうの紙面 ▸ 脳卒中 × 嚥下障害 ▸ 骨折 × 回復期リハ ▸ 介護報酬 × 老健 ▸ 短信 8本

■ 脳卒中 × 嚥下障害

脳卒中後の嚥下障害1,286人 6か月で経口摂取が回復は60.3%

筋量・握力・栄養・造影所見が回復しにくさと関連　単施設・後ろ向き

脳卒中後の嚥下障害で、6か月後の経口摂取の回復と関連する因子を調べた単施設の後ろ向きコホート研究が、2026年11月に掲載された。対象は脳梗塞または脳出血で嚥下障害があり、開始時の経口摂取尺度（FOIS）が1〜4だった1,286人で、発症から180日以内に嚥下造影検査を受けている。

6か月時点で生存していた1,241人のうち748人（60.3%）が、多種の食形態での完全経口摂取（FOIS 5以上）に達した。回復しにくさと関連したのは、骨格筋量指数の低さ（調整オッズ比0.67、95%CI 0.50〜0.90）、握力の低さ（0.69、0.51〜0.92）、栄養リスク指数（GNRI）98未満（0.75、0.56〜1.00）、誤嚥・侵入の重症度（PAS）6以上（0.60）、喉頭蓋谷の中等度〜重度の残留（0.65）、梨状陥凹の同残留（0.57、0.42〜0.77）だ。

脳卒中の重症度、認知機能、失語、病巣、主な併存症で調整している。後ろ向きの単施設研究で因果は言えず、GNRIは信頼区間の上限が1.00に届く。造影所見に筋量・握力・栄養を並べて見ることが、経口摂取の見通しを立てる材料になる。



造影所見と全身状態を並べて、経口摂取の見通しを立てる。

出典 PubMed収録論文（2026年11月号）↗

数字で見る

1,286人
対象（FOIS 1〜4）

60.3%
6か月で完全経口摂取に到達

0.57
梨状陥凹の残留の調整オッズ比

■ 骨折 × 回復期リハ

骨粗鬆症性骨折115人、下肢の位相角が高いほど退院時FIM運動が良好

回復期リハ病棟に入院した骨粗鬆症性骨折の患者115人（女性97人、年齢81.0±10.0歳）で、部位別の位相角と退院時の状態の関連を調べた後ろ向きコホート研究。入院時の位相角の中央値は3.6°だった。交絡を調整した重回帰で、下肢の位相角は退院時のFIM運動項目（β=0.077、P=0.045）、握力（β=0.174）、骨格筋量指数（β=0.154）と独立に関連した。



FIM運動項目はP=0.045とぎりぎりで係数も小さい。位相角を上げる介入の効果を示した研究ではなく、入院時の測定から退院時を見通す一つの目安にとどまる。

出典 Injury↗

■ 介護報酬 × 老健

老健の短期集中リハ2加算 算定要件を揃える案を提示

厚生労働省は11月2日の社会保障審議会・介護給付費分科会で、令和9年度介護報酬改定へ向けた老健の見直し案を示した。短期集中リハビリテーション実施加算と認知症短期集中リハビリテーション実施加算で、入所者が入院した後の取扱いなど算定要件が異なるため、揃える方向だ。

地域ケア会議などへのリハ専門職の関与を、居宅サービスの実施数の基準にある「地域に貢献する活動」として明確化する案もある。老健協会の会長は、退所先が未定の利用者で訪問要件を満たせないとして柔軟化を求めた。点数や要件の中身は今後の議論で変わる。



出典 GemMed／POST↗

短信

〈医療AI〉 **リハ計画へのLLM、9研究のSR**
専門家の確認後の一致は98.75%だが幻覚の報告もあり、監督が要ると結論。 出典 PubMed↗

〈大腿骨骨折〉 **術後ケア必要度の3類型（英国）**
登録63,108人。自宅に戻れなかった割合は18.4%、39.5%、73.8%と段階的に上昇。 出典 PubMed↗

〈認知症〉 **認知症を伴う大腿骨骨折の総説**
認知機能の低下は、手術やリハを控える理由にならないと整理。中重度の直接の根拠は乏しい。 出典 PubMed↗

〈嚥下〉 **脳卒中後嚥下障害への鍼、SR45件**
36件は方法論の質が非常に低く、確実性の大半は低〜非常に低い。補助的な位置づけ。 出典 PubMed↗

〈環境〉 **脳卒中後の在宅・近隣環境の探索**
アクセス、日常サービスへの近さ、人との接点が揃うほど支えと認識された。探索研究。 出典 PubMed↗

〈神経難病〉 **多発性硬化症の運動促進、28介入**
行動戦略や追跡評価などが推奨と合っておらず、設計の見直しが課題とするスコーピングレビュー。 出典 PubMed↗

〈呼吸リハ〉 **仮想呼吸リハ2,444人、METs改善**
最大METs・DASI・PHQ-9の効果量が大きい。対照群なしの後ろ向き観察で、91%が固定収入。 出典 PubMed↗

〈肩〉 **五十肩の水圧拡張、RCT20件のNMA**
1,410人。腱板疎部のステロイド水圧拡張が痛みを下げ（SMD -1.30）、外旋改善と関連。 出典 PubMed↗